Gestión de Muestras · 1er examen · Simulacro Test

Tema 1 · Examen: 15.oct · 120 preguntas · cubre los 75 conceptos del tema · una sola respuesta correcta · soluciones al final

Hazlo sin mirar los apuntes. Puedes hacerlo en dos partes: preguntas 1–50 (unos 45 minutos) y 51–100 (otros 45). Rodea tu respuesta, corrige al final y repasa en el archivo de estudio las que falles.

Sistema sanitario, salud y determinantes

1. Según la OMS, el sistema sanitario es:
a) El conjunto de hospitales y centros de salud públicos
b) El conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a la salud en hogares, trabajo, lugares públicos y comunidades
c) El conjunto de profesionales sanitarios colegiados
d) La red de servicios financiada con impuestos

2. El principio de equidad significa:
a) Dar exactamente lo mismo a todas las personas
b) Que la sanidad sea gratuita para todos
c) Dar a cada persona la atención que necesita para lograr el mejor nivel de salud posible
d) Gastar lo menos posible en cada paciente

3. "Conseguir los mejores resultados en salud utilizando los recursos de la mejor manera posible" define el principio de:
a) Eficiencia
b) Universalidad
c) Atención integral
d) Equidad

4. El principio de atención integral consiste en:
a) Atender solo la enfermedad que motiva la consulta
b) Considerar a la persona como un todo: aspectos físicos, psicológicos y sociales
c) Atender a toda la población sin excepciones
d) Integrar la sanidad pública y la privada

5. La OMS definió en 1948 la salud como:
a) La ausencia de enfermedad
b) Un derecho humano fundamental
c) Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad
d) La capacidad de funcionamiento de la persona

6. La conferencia de Alma-Ata (1978) destacó la importancia de:
a) La atención hospitalaria
b) Los seguros privados

c) La atención primaria
d) La investigación biomédica

7. En el modelo de Lalonde (1974), el determinante que más influye en la salud es:
a) La biología humana
b) El estilo de vida
c) El medio ambiente
d) El sistema de asistencia sanitaria

8. En el modelo de Lalonde, el determinante con menor peso es:
a) El sistema de asistencia sanitaria
b) La biología humana
c) El medio ambiente
d) El estilo de vida

9. Tener antecedentes familiares de diabetes es un ejemplo de determinante:
a) Estilo de vida
b) Medio ambiente
c) Sistema sanitario
d) Biología humana

10. Sobre los estilos de vida, es correcto que:
a) Dependen exclusivamente de las decisiones individuales
b) Las condiciones sociales y económicas pueden facilitar o dificultar hábitos saludables
c) Incluyen la genética y la edad
d) Son el determinante con menos peso según Lalonde

11. El modelo de Dahlgren y Whitehead (1991) representa los determinantes:
a) En forma de pirámide
b) En un gráfico de sectores con porcentajes
c) Mediante capas concéntricas alrededor de la persona
d) En una línea temporal

12. En el modelo de Dahlgren y Whitehead, cuanto más externa es una capa:
a) Más depende de las decisiones individuales
b) Menos depende de las decisiones individuales y más de las condiciones sociales y económicas
c) Menos influye en la salud
d) Más relación tiene con la genética

13. En los países pobres siguen pesando mucho:
a) Las enfermedades cardiovasculares
b) El cáncer y la diabetes
c) Las enfermedades infecciosas y la mortalidad infantil
d) Las enfermedades crónicas

Funciones y modelos sanitarios

14. Las vacunaciones y los programas de cribado son actuaciones de:
a) Rehabilitación
b) Prevención

c) Tratamiento
d) Promoción de la salud

15. Las tres preguntas a las que responde todo sistema sanitario se refieren a:
a) Financiación, provisión y acceso
b) Prevención, tratamiento y rehabilitación
c) Universalidad, equidad y eficiencia
d) Estado, comunidades y municipios

16. Los modelos sanitarios representan:
a) Los hospitales de referencia de cada país
b) Los criterios doctrinales e ideológicos sobre los que se basan los sistemas sanitarios
c) La cartera de servicios de cada sistema
d) Los códigos deontológicos de los profesionales

17. En el modelo liberal, el acceso a la sanidad depende de:
a) La residencia en el país
b) Haber cotizado a la Seguridad Social
c) La capacidad económica o la póliza contratada
d) La decisión del Estado

18. El principal beneficio del modelo liberal es:
a) La universalidad
b) La equidad
c) Los avances tecnológicos por la competencia entre proveedores
d) El bajo coste del sistema

19. En Estados Unidos, el programa público para mayores de 65 años es:
a) Medicaid
b) Medicare
c) Obamacare
d) NHS

20. El modelo social o Semashko se caracteriza por:
a) Financiación con cotizaciones de trabajadores y empresas
b) Ser responsabilidad exclusiva del Estado, que lo financia y lo gestiona todo
c) La salud como un bien que se compra y se vende
d) Combinar financiación pública y privada

21. El ejemplo actual más citado de modelo social es:
a) Alemania
b) Reino Unido
c) Estados Unidos
d) Cuba

22. El modelo Bismarck se financia mediante:
a) Impuestos generales
b) Cotizaciones sociales obligatorias de trabajadores y empresas
c) Seguros privados voluntarios
d) Pagos directos del paciente

23. El modelo Bismarck nació en:
a) Reino Unido, en 1942
b) La Unión Soviética, en 1917
c) Alemania, en 1883
d) Francia, en 1948

24. En el modelo Bismarck, la asistencia a las personas desempleadas se cubre mediante:
a) La beneficencia
b) Seguros privados
c) Impuestos especiales
d) No se cubre de ninguna forma

25. El modelo Beveridge:
a) Se financia con impuestos generales y su cobertura es universal
b) Se financia con cotizaciones y cubre solo a los trabajadores
c) Es exclusivamente privado
d) Nació en Alemania

26. La gran crítica al modelo Beveridge son:
a) Las facturas médicas
b) Las listas de espera
c) La falta de cobertura de los desempleados
d) La selección de riesgos por las aseguradoras

27. El modelo mixto:
a) Solo existe en Estados Unidos
b) Está presente en la mayoría de los países occidentales y tiene dos variantes: Bismarck y Beveridge
c) Excluye cualquier participación privada
d) Lo diseñó Nikolái Semashko

Sistema Nacional de Salud

28. El sistema sanitario español sigue el modelo:
a) Liberal
b) Bismarck
c) Beveridge
d) Social

29. La transición de España hacia el modelo actual empezó con:
a) La Constitución de 1978
b) La Ley General de Sanidad de 1986
c) La Ley 16/2003
d) El Real Decreto-ley 7/2018

30. El derecho a la protección de la salud está recogido en la Constitución Española, artículo:
a) 14
b) 27
c) 43
d) 149

31. La ley que crea el Sistema Nacional de Salud es:
a) Ley 14/1986, General de Sanidad
b) Ley 16/2003, de cohesión y calidad
c) Ley 44/2003, LOPS
d) Ley 41/2002

32. El Real Decreto-ley 7/2018:
a) Restringió el acceso a los "asegurados"
b) Amplió el copago a los pensionistas
c) Recuperó la universalidad, vinculando el derecho a la residencia
d) Creó el Consejo Interterritorial

33. La gestión de la asistencia sanitaria en España corresponde a:
a) El Ministerio de Sanidad
b) Las comunidades autónomas, a través de su servicio de salud
c) Los ayuntamientos
d) La Seguridad Social

34. En Ceuta y Melilla, la asistencia sanitaria la gestiona:
a) El SAS
b) Osakidetza
c) El INGESA
d) La AEMPS

35. El órgano que conecta al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas es:
a) El Observatorio del SNS
b) La Agencia de Calidad
c) El Consejo Interterritorial del SNS
d) La Comisión Consultiva Profesional

36. La vigilancia de los medicamentos una vez comercializados se llama:
a) Farmacovigilancia
b) Vigilancia epidemiológica
c) Triaje
d) Cribado

37. Sobre los medicamentos, es correcto que:
a) El Ministerio los autoriza y la AEMPS fija el precio
b) La AEMPS los autoriza y el Ministerio de Sanidad decide cuáles se financian y a qué precio
c) Las comunidades autónomas autorizan los medicamentos
d) La farmacia hospitalaria tiene copago según renta

Organización asistencial y cartera

38. La puerta de entrada al sistema sanitario es:
a) Urgencias hospitalarias
b) La atención especializada
c) La atención primaria
d) La farmacia

39. El servicio de Anatomía Patológica se sitúa en:
a) La atención primaria
b) La atención especializada
c) La salud pública
d) Los centros de salud

40. La función de "servicio de medios" (más tecnología y métodos diagnósticos) es propia de:
a) La atención primaria
b) La atención especializada
c) La salud pública
d) Las urgencias extrahospitalarias

41. Las áreas de salud están vinculadas generalmente a:
a) Un centro de salud
b) Un hospital de referencia
c) Un ayuntamiento
d) Una farmacia

42. La cartera común básica de servicios es:
a) Totalmente gratuita en el momento de uso
b) Con aportación del usuario
c) Exclusiva de cada comunidad autónoma
d) De actividades de apoyo

43. Sobre el triaje, es correcto que:
a) Decide qué pacientes se atienden y cuáles no
b) Lo realiza siempre el médico especialista
c) Clasifica la prioridad según la gravedad y usa sistemas de 5 niveles
d) Tiene 3 niveles de prioridad

44. Una férula o un corsé son ejemplos de:
a) Prótesis
b) Ortesis
c) Productos dietéticos
d) Transporte sanitario

Deontología, bioética y LOPS

45. Los códigos deontológicos:
a) Son siempre leyes de obligado cumplimiento
b) No siempre son legalmente vinculantes, pero los aplican los colegios profesionales
c) Solo afectan a los médicos
d) Los aprueba el Parlamento

46. El término "bioética" lo acuñó:
a) Avedis Donabedian, 1980
b) Van Rensselaer Potter, 1971
c) Tom Beauchamp, 1979
d) Marc Lalonde, 1974

47. El principio de bioética relacionado con el consentimiento informado es:
a) Justicia
b) Beneficencia
c) No maleficencia
d) Autonomía

48. La Ley 44/2003 (LOPS) regula:
a) La creación del Sistema Nacional de Salud
b) La cartera de servicios
c) Las profesiones sanitarias, es decir, a las personas que trabajan en el sistema
d) El acceso universal a la sanidad

49. Según la LOPS, el Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico pertenece al grupo de:
a) Profesiones sanitarias tituladas, nivel diplomado
b) Profesionales del área sanitaria de formación profesional
c) Profesiones sanitarias tituladas, nivel licenciado
d) Personal no sanitario

Economía y calidad

50. Comparar dos tratamientos igual de efectivos y elegir el más barato es un análisis de:
a) Coste-beneficio
b) Coste-efectividad
c) Coste-utilidad
d) Coste-minimización

Economía y calidad (continuación)

51. España dedica a la sanidad alrededor de:
a) El 3 % del PIB
b) El 10 % del PIB
c) El 25 % del PIB
d) El 50 % del PIB

52. La pérdida de productividad y el tiempo de cuidado informal son costes:
a) Directos sanitarios
b) Directos no sanitarios
c) Indirectos
d) Intangibles

53. Los costes más difíciles de medir, como el dolor o la ansiedad, son:
a) Directos
b) Indirectos
c) Intangibles
d) De oportunidad

54. El análisis coste-utilidad mide los resultados en:
a) Dinero
b) QALY (años de vida ajustados por calidad)

c) Casos evitados
d) Número de pacientes atendidos

55. Las fases del ciclo de Deming son:
a) Planificar, hacer, verificar y actuar
b) Estructura, proceso y resultado
c) Liderazgo, procesos y resultados
d) Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación

56. Las tres dimensiones del modelo de calidad de Donabedian son:
a) Eficacia, efectividad y eficiencia
b) Estructura, proceso y resultado
c) Accesibilidad, seguridad y calidad
d) Clientes, personas y sociedad

57. "¿Funciona en la práctica real?" es la pregunta de la:
a) Eficacia
b) Efectividad
c) Eficiencia
d) Equidad

58. España es líder mundial en:
a) Gasto sanitario por habitante
b) Donación de órganos
c) Médicos por habitante
d) Cribado de cáncer de cérvix

59. La partida más importante del gasto sanitario público es:
a) Los fármacos
b) La alta tecnología
c) El personal sanitario
d) Las infraestructuras

60. El Código de Deontología Médica vigente se publicó en:
a) 1986
b) 2003
c) 2011
d) 2018

Parte 2 · Repaso completo de todos los conceptos

61. En el esquema del sistema sanitario, en el centro se sitúa:
a) La persona y su salud
b) El hospital
c) El Ministerio de Sanidad
d) El médico de familia

62. El principio de universalidad establece que:
a) Cada persona recibe lo que necesita
b) Todas las personas tienen derecho a recibir atención sanitaria, independientemente de su situación económica o social

c) El sistema se adapta a los nuevos problemas de salud
d) Se atiende a la persona como un todo

63. El principio de adaptación a las necesidades de la población incluye:
a) Reducir el gasto al mínimo
b) Dar a todos exactamente lo mismo
c) Detectar los nuevos problemas de salud e intentar prevenirlos
d) Atender solo a quien paga

64. El concepto ampliado de salud añade que el nivel de salud está condicionado por:
a) Los factores sociales y la capacidad de funcionamiento de la persona
b) El número de hospitales
c) Solo la genética
d) El gasto sanitario del país

65. En el modelo de Lalonde, la biología humana representa aproximadamente:
a) El 11 %
b) El 19 %
c) El 27 %
d) El 43 %

66. El medio ambiente, según Lalonde, se divide en:
a) Medio urbano y medio rural
b) Medio físico y medio social
c) Medio interno y medio externo
d) Medio laboral y medio familiar

67. "Es lo que hacemos y cómo vivimos" describe el determinante:
a) Biología humana
b) Sistema sanitario
c) Estilos de vida
d) Medio ambiente

68. Los programas de vacunación, la atención primaria y la rehabilitación pertenecen al determinante:
a) Sistema de asistencia sanitaria
b) Biología humana
c) Estilos de vida
d) Medio ambiente

69. El modelo de Dahlgren y Whitehead es importante porque:
a) Es uno de los más importantes después del de Lalonde
b) Solo tiene en cuenta la genética
c) Sustituye a la definición de salud de la OMS
d) Es el primer modelo de determinantes de la historia

70. "Recuperar o mantener la capacidad funcional" define la actuación de:
a) Promoción de la salud
b) Detección precoz
c) Prevención
d) Rehabilitación

71. Los países organizan su sanidad de forma distinta porque:
a) Cada sociedad tiene una situación económica, política, social y cultural diferente
b) No existe ningún modelo de referencia
c) La OMS les obliga a usar modelos distintos
d) Tienen objetivos de salud diferentes

72. La pregunta "¿quién presta el servicio?" se refiere a:
a) La regulación
b) La financiación
c) El acceso
d) La provisión

73. En el modelo liberal, la "selección de riesgos" significa que:
a) A las aseguradoras les interesa cubrir a personas sanas y los crónicos pagan más
b) Los médicos eligen a sus pacientes por sorteo
c) El Estado selecciona a los pacientes más graves
d) Se priorizan las urgencias

74. Sobre la esperanza de vida en Estados Unidos, es correcto que:
a) Es la más alta del mundo
b) Es inferior a la de otros países ricos con sanidad universal
c) Es igual a la de Cuba
d) No se puede medir

75. El modelo social lo diseñó:
a) Otto von Bismarck
b) Marc Lalonde
c) William Beveridge
d) Nikolái Semashko

76. Un inconveniente del modelo social es:
a) La exclusión de quien no puede pagar
b) El encarecimiento del empleo por las cotizaciones
c) El doble aseguramiento
d) La nula libertad de elección de médico y centro

77. El modelo mixto se basa en fomentar:
a) La hospitalización y la cirugía
b) La promoción, la prevención y la atención primaria
c) Los seguros privados
d) La competencia entre aseguradoras

78. Un país con modelo Bismarck es:
a) España
b) Cuba
c) Reino Unido
d) Francia

79. El Informe Beveridge (1942) inspiró la creación en 1948 de:
a) Medicare
b) El SNS español

c) El NHS (National Health Service)
d) La OMS

80. El "doble aseguramiento" en el modelo Beveridge consiste en:
a) Cotizar en dos cajas a la vez
b) Tener dos tarjetas sanitarias
c) Estar asegurado en dos comunidades autónomas
d) Pagar impuestos y además un seguro privado para evitar esperas

81. Antes de los años 80, España tenía un modelo:
a) Social
b) Liberal
c) Bismarck ("el médico del seguro")
d) Beveridge

82. La Constitución de la OMS, que reconoce la salud como derecho fundamental, es de:
a) 1948
b) 1978
c) 1986
d) 1946

83. La Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS:
a) Busca prestaciones comunes y de calidad similar en todas las comunidades y define la cartera común
b) Crea el Sistema Nacional de Salud
c) Restringe el acceso a los asegurados
d) Regula las profesiones sanitarias

84. El Real Decreto-ley 16/2012:
a) Recuperó la universalidad
b) Creó la AEMPS
c) Restringió el acceso a los "asegurados" y amplió el copago farmacéutico
d) Aprobó el Código de Deontología Médica

85. Que el SNS sea "descentralizado" significa que:
a) No tiene hospitales públicos
b) Se financia con seguros privados
c) Lo gestionan las comunidades autónomas
d) Lo gestiona el Ministerio de Sanidad

86. Una competencia que se reserva el Estado es:
a) Organizar los centros de salud
b) Contratar al personal de los centros de salud
c) La sanidad exterior (puertos, aeropuertos y fronteras)
d) Gestionar los hospitales de cada comunidad

87. El servicio de salud de Navarra se llama:
a) Osasunbidea
b) Osakidetza
c) SERMAS
d) SERGAS

88. La AEMPS también supervisa:
a) El triaje de urgencias
b) Los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y los cosméticos
c) Los salarios del personal sanitario
d) Las listas de espera

89. La Tarjeta Sanitaria Europea permite:
a) Cambiar de comunidad autónoma de residencia
b) Recibir asistencia sanitaria necesaria durante estancias temporales en la UE, el EEE, Suiza y Reino Unido
c) Comprar medicamentos sin receta en Europa
d) Asistencia gratuita ilimitada en cualquier país del mundo

90. Tras el tratamiento en atención especializada, el paciente vuelve a primaria. Esto se llama:
a) Servicio de medios
b) Continuidad asistencial
c) Derivación inversa
d) Accesibilidad

91. Cada zona básica de salud tiene:
a) Su hospital de referencia
b) Su consejo interterritorial
c) Su centro de salud
d) Su propia ley sanitaria

92. La cartera de servicios del SNS está regulada por:
a) El RDL 7/2018 y el RDL 16/2012
b) La Ley 16/2003 y el Real Decreto 1030/2006
c) La Ley 14/1986 y la Constitución
d) La Ley 44/2003 y la Ley 41/2002

93. La cartera complementaria es:
a) Las actividades de apoyo
b) Los servicios extra que añade cada comunidad autónoma
c) Con aportación del usuario
d) Totalmente gratuita en todo el país

94. La salud pública:
a) Protege, promueve y preserva la salud de toda la comunidad
b) Atiende solo al individuo enfermo
c) Es un servicio privado
d) Solo realiza cirugías

95. La farmacia hospitalaria es:
a) Privada
b) Solo para pensionistas
c) Gratuita
d) Con copago según renta

96. La nutrición enteral forma parte de la prestación de:
a) Ortoprótesis

b) Transporte sanitario
c) Salud pública
d) Productos dietéticos

97. Los principios de la bioética los establecieron:
a) Tom Beauchamp y James Childress
b) Van Rensselaer Potter y Lalonde
c) Dahlgren y Whitehead
d) Deming y Donabedian

98. El consentimiento informado está regulado por:
a) La Ley 44/2003
b) El RDL 7/2018
c) La Ley 14/1986
d) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre

99. "No causar daño de forma intencionada" corresponde al principio de:
a) Justicia
b) Autonomía
c) Beneficencia
d) No maleficencia

100. El primer bloque del Código de Deontología Médica de 2011 trata sobre:
a) El comportamiento del médico, el secreto profesional y el final de la vida
b) Las relaciones con otras profesiones sanitarias
c) La economía de la salud
d) La relación de los médicos con el sistema sanitario

Parte 3 · Bonus de calidad, economía y LOPS (para ganarlo sobrado)

101. Una novedad del Código de Deontología de 2011 es:
a) Prohibir la formación continua
b) Suprimir el consentimiento informado
c) Eliminar la historia clínica
d) Registrar informáticamente la historia clínica y proteger los datos clínicos

102. Según la LOPS, Enfermería y Fisioterapia son profesiones tituladas de nivel:
a) Técnico superior
b) Licenciado
c) Diplomado (hoy grado)
d) Técnico de grado medio

103. Cuidados Auxiliares de Enfermería es una titulación de:
a) Máster
b) Técnico superior
c) Técnico de grado medio
d) Grado universitario

104. Según la LOPS, la relación entre profesionales se basa en:
a) La competencia entre profesiones
b) La jerarquía rígida
c) La antigüedad
d) La cooperación y el trabajo interdisciplinar

105. La formación del médico especialista en Anatomía Patológica es:
a) 2 años de FP
b) 4 años de residencia tras aprobar el MIR
c) No necesita formación especializada
d) Un máster de 1 año

106. El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios sirve para:
a) Asignar médico de cabecera
b) Gestionar las listas de espera
c) Comprobar quién está habilitado para ejercer
d) Fijar los salarios

107. El coste de oportunidad significa que:
a) Los tratamientos baratos son siempre mejores
b) Cada euro gastado en algo deja de gastarse en otra cosa
c) El gasto público no tiene límite
d) La sanidad es gratuita

108. Una causa del aumento del gasto sanitario es:
a) El envejecimiento y la cronicidad
b) El aumento de la natalidad
c) La reducción de la tecnología
d) La disminución de las expectativas de la población

109. Las mejoras del sistema sanitario van enfocadas, entre otras cosas, a:
a) Eliminar las herramientas digitales
b) Privatizar todo el sistema
c) Reducir la atención primaria
d) La sostenibilidad del sistema y la atención integral del paciente

110. Un diagnóstico tardío, frente a uno precoz:
a) Es más barato
b) Suele ser mucho más caro (más tratamientos, ingresos y peor pronóstico)
c) No influye en el gasto
d) Cuesta lo mismo

111. Los CSUR son:
a) Centros de salud urbanos rurales
b) Consejos de salud de las comunidades
c) Comisiones sanitarias de urgencias
d) Centros, servicios y unidades de referencia que concentran los casos complejos o poco frecuentes

112. El programa que agrupa las guías de práctica clínica en España es:
a) Euskalit

b) EFQM
c) GuíaSalud
d) INGESA

113. El registro de acontecimientos adversos sirve para:
a) Registrar a los profesionales
b) Autorizar medicamentos
c) Recoger errores e incidentes, aprender de ellos y evitar que se repitan
d) Medir el gasto

114. El Observatorio del SNS:
a) Analiza el funcionamiento del sistema y compara comunidades
b) Realiza el triaje
c) Gestiona Ceuta y Melilla
d) Autoriza los medicamentos

115. Según Donabedian, la calidad es la que proporciona al usuario el máximo bienestar tras valorar:
a) El balance de ganancias y pérdidas del proceso
b) El tiempo de espera
c) La opinión del médico
d) El coste total

116. NO es uno de los 7 pilares de la calidad de Donabedian:
a) Aceptabilidad
b) Eficacia
c) Legitimidad
d) Rentabilidad

117. En el modelo de Donabedian, los equipos, el personal y las instalaciones pertenecen a la dimensión de:
a) Acreditación
b) Estructura
c) Resultado
d) Proceso

118. Los costes de transporte en ambulancia y la ayuda en el domicilio son costes:
a) Indirectos
b) Directos no sanitarios
c) Directos sanitarios
d) Intangibles

119. El modelo de calidad basado en la autoevaluación es:
a) ISO 9001
b) EFQM
c) Joint Commission
d) Deming

120. En el centro del modelo Euskalit están:
a) Los resultados
b) Las personas

c) Los clientes
d) La innovación

Soluciones

Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.
1	b	16	b	31	a	46	b
2	c	17	c	32	c	47	d
3	a	18	c	33	b	48	c
4	b	19	b	34	c	49	b
5	c	20	b	35	c	50	d
6	c	21	d	36	a	51	b
7	b	22	b	37	b	52	c
8	a	23	c	38	c	53	c
9	d	24	a	39	b	54	b
10	b	25	a	40	b	55	a
11	c	26	b	41	b	56	b
12	b	27	b	42	a	57	b
13	c	28	c	43	c	58	b
14	b	29	b	44	b	59	c
15	a	30	c	45	b	60	c

Soluciones 61–120

Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.
61	a	76	d	91	c	106	c
62	b	77	b	92	b	107	b
63	c	78	d	93	b	108	a
64	a	79	c	94	a	109	d
65	c	80	d	95	c	110	b
66	b	81	c	96	d	111	d
67	c	82	d	97	a	112	c
68	a	83	a	98	d	113	c
69	a	84	c	99	d	114	a
70	d	85	c	100	a	115	a
71	a	86	c	101	d	116	d
72	d	87	a	102	c	117	b
73	a	88	b	103	c	118	b

Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.
74	b	89	b	104	d	119	b
75	d	90	b	105	b	120	a

Cómo corregirte: cuenta los aciertos por partes. Con un 80 % o más en cada parte vas sobrado. Busca cada fallo en el archivo de estudio y repite su pregunta abierta.